

Số: 194 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc kháng sinh Cefoperazon 1000 mg

Để có thêm lựa chọn thuốc kháng sinh cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc Cefoperazon 1000 mg. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần: Cefoperazon natri tương đương Cefoperazon 1000 mg. Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3
- Dạng bào chế: bột pha tiêm, màu trắng đến vàng nhạt, đóng lọ thủy tinh trung tính, đậy kín bằng nút cao su và nắp nhôm.
- Cơ chế tác dụng: Cefoperazon là kháng sinh beta-lactam có tác dụng diệt khuẩn do gắn vào protein gắn penicillin (PBP), ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn, làm vi khuẩn bị ly giải và chết.
- Phổ tác dụng: Vi khuẩn Gram dương hiếu khí: *Staphylococcus aureus* nhạy methicillin (MSSA), *Staphylococcus epidermidis* (chúng nhạy cảm),.... Không có tác dụng trên MRSA và Enterococcus spp. Vi khuẩn Gram âm hiếu khí: *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*. Không có tác dụng trên Acinetobacter spp. Vi khuẩn kỵ khí: *Bacteroides spp.* (mức trung bình), *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Clostridium spp.* (không bao gồm *C. difficile*).

2. Thuốc được chỉ định trong các trường hợp:

- Nhiễm khuẩn hô hấp dưới: viêm phổi, viêm phế quản.
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
- Nhiễm khuẩn huyết.
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm.
- Nhiễm khuẩn ổ bụng, viêm phúc mạc.
- Nhiễm khuẩn phụ khoa.
- Dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật: vùng bụng, phụ khoa, tim mạch và chỉnh hình.

3. Các chống chỉ định của thuốc

- Quá mẫn với cefoperazon hoặc các kháng sinh nhóm cephalosporin.
- Tiền sử phản vệ hoặc phản ứng da nặng (hội chứng Stevens-Johnson, Lyell) với kháng sinh beta-lactam.

4. Cách pha và cách dùng

- Tiêm bắp: Hoàn nguyên 1 g bột với khoảng 2,6–3 ml nước cất pha tiêm. Có thể pha với lidocain 1% hoặc 2% để giảm đau (không dùng lidocain cho đường tĩnh mạch).
- Tiêm tĩnh mạch: Hoàn nguyên với nước cất pha tiêm hoặc dung dịch NaCl 0,9%, tiêm chậm trong 3–5 phút.
- Truyền tĩnh mạch: Sau khi hoàn nguyên, pha loãng thêm bằng dung dịch NaCl 0,9%, glucose 5% hoặc Ringer lactat. Truyền trong khoảng 15–30 phút.

5. Tương kỵ của thuốc

- Không pha chung trong cùng dây truyền với aminoglycosid; nếu phối hợp cần truyền riêng và tráng dây truyền giữa các lần dùng thuốc.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhân:

- Chủ tịch HĐQT (b/c):
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo):
- Các khoa lâm sàng:
- Lưu VT; KD.

TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI